

Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives supérieures

Pr Christophe Le Tourneau¹, Pr Jean-Pierre Delord², Pr Anne Laprie³, Pr Philippe Maingon⁴,
Pr Florian Clatot⁵, Pr Sophie Deneuve⁶

¹Département d'Oncologie médicale, Institut Curie, Paris et Saint-Cloud

²Département d'Oncologie médicale, Institut Universitaire de Cancérologie de Toulouse – Oncopole, Toulouse

³Département d'Oncologie radiothérapie, Institut Universitaire de Cancérologie de Toulouse – Oncopole, Toulouse

⁴Département de Radiothérapie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris

⁵Service d'oncologie médicale, Centre Henri-Becquerel, Rouen

⁶Service de chirurgie ORL, CHU de Rouen

OBJECTIFS : N° 298. Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives supérieures

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur de la cavité buccale, naso-sinusienne ou du cavum, ou des voies aérodigestives supérieures.

- | | |
|---|---|
| 1. Généralités anatomiques des VADS | 7. Évolution et pronostic |
| 2. Principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes ORL par localisation (hors glandes salivaires) | 7.1. Cancers de l'oropharynx, hypopharynx, larynx et de la cavité buccale |
| 3. Histoire naturelle, facteurs de risque des cancers des VADS | 7.2. Tumeurs des fosses nasales et des sinus |
| 3.1. Facteurs de risque | 7.3. Tumeurs du cavum |
| 3.2. Histoire naturelle | 8. Généralités sur la prévention en cancérologie des VADS |
| 4. Généralités épidémiologiques des cancers des VADS | 9. Approches thérapeutiques |
| 5. Diagnostic positif | 9.1. Principes généraux |
| 5.1. Circonstances de découverte | 9.2. Cancers de l'oropharynx, hypopharynx, larynx et de la cavité buccale |
| 5.2. Diagnostic de certitude | 9.3. Tumeurs des fosses nasales et des sinus |
| 6. Éléments du bilan des cancers des VADS | 9.4. Tumeurs du cavum |
| 6.1. Bilan d'extension | |
| 6.2. Bilan pré-thérapeutique | |
| 6.3. Classification TNM | |

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les généralités anatomiques des cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes ORL par localisation (hors glandes salivaires)
B	Physiopathologie	Connaître l'histoire naturelle et les facteurs de risque des cancers VADS
B	Épidémiologie	Connaître les généralités épidémiologiques des cancers VADS
A	Diagnostic positif	Connaître les signes cliniques des cancers de la cavité buccale, des cancers naso-sinusiens ou des cancers VADS
B	 Contenu multimédia	Iconographies cliniques typiques des principales formes de carcinome épidermoïde de l'amygdale palatine
A	 Contenu multimédia	Iconographies cliniques typiques des principales formes de carcinome épidermoïde de la langue
B	Contenu multimédia	Photographie d'une leucoplasie de la face interne de joue
B	Examens complémentaires	Connaître l'indication de l'imagerie devant un cancers VADS
A	Prise en charge	Connaître les généralités sur la prévention en cancérologie VADS



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

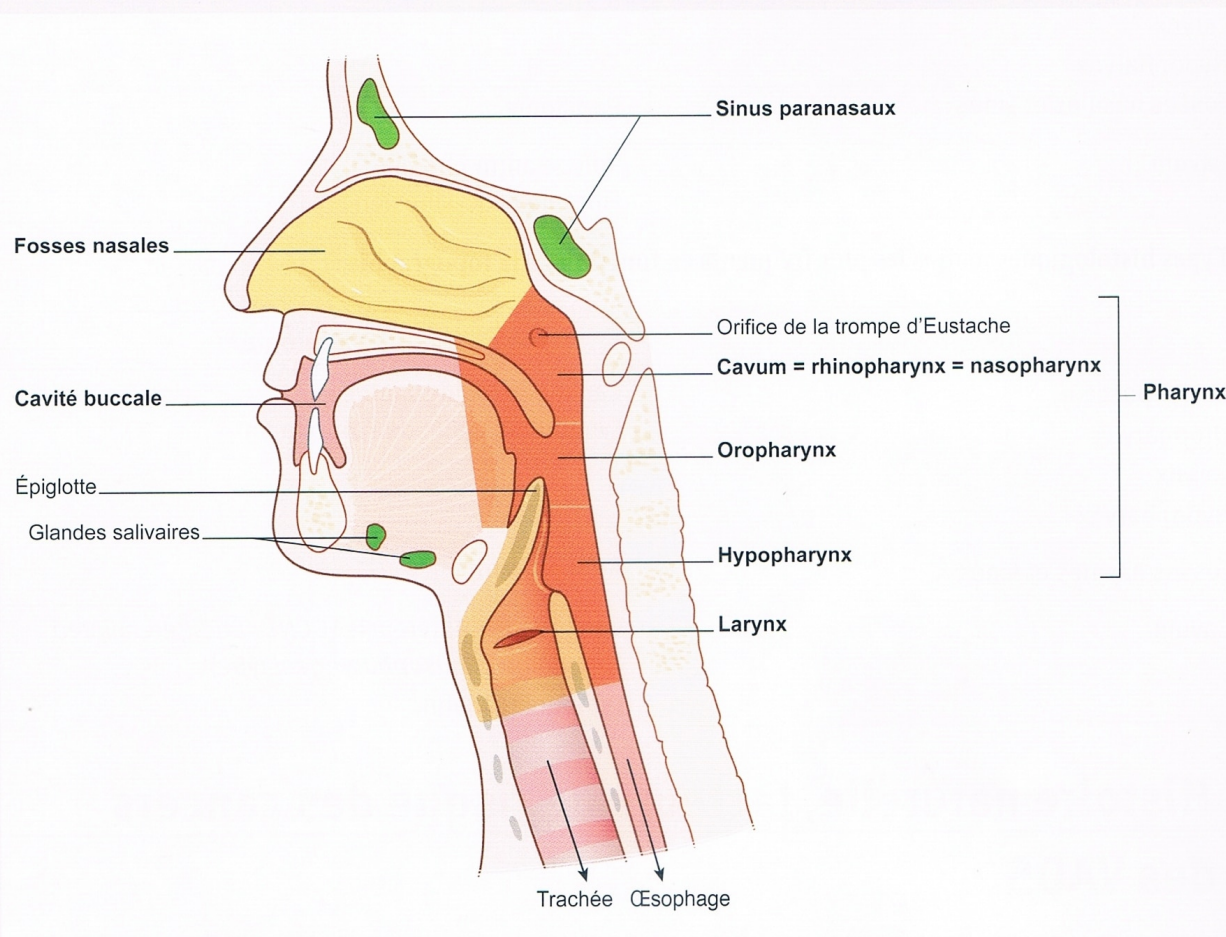
- **Les cancers des voies aérodigestives supérieures présentent de grandes disparités** selon leur origine, leur localisation, leur retentissement fonctionnel et leurs modalités thérapeutiques.
- Classiquement, **on distingue les cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx, voies communes du tractus aéro-digestif, et les cancers du larynx et de l'hypopharynx**, spécifiques respectivement des voies aérienne et digestive. Ces cancers sont principalement observés chez des patients éthylo-tabagiques. La double intoxication multiplie les risques connus de l'une et de l'autre des intoxications. Un changement de l'épidémiologie de ces cancers est constaté avec l'émergence récente de cancers de l'oropharynx associés au virus HPV.
- **Les cancers des sinus de la face constituent une entité clinique particulière** et doivent faire rechercher une origine toxique. Les cancers du cavum (encore appelé rhinopharynx ou nasopharynx) sont associés au virus Epstein-Barr (EBV). Ils se caractérisent par une épidémiologie particulière avec des zones de forte endémie comme la Chine du Sud, des zones intermédiaires comme le pourtour méditerranéen et des zones d'endémie plus faible comme l'Europe occidentale.
- **Chaque type tumoral correspond à une segmentation anatomique précise** pour laquelle les risques d'extension sont spécifiques à l'anatomie loco-régionale. Les probabilités d'extension ganglionnaire, corrélées au site tumoral primitif, à la taille tumorale et aux caractéristiques anatomo-pathologiques de la tumeur, sont décrites avec leurs localisations précises.
- **Le bilan de ces affections est bien codifié.** Il ne doit pas négliger le contexte général du patient, ses conditions de vie, ses comorbidités souvent nombreuses qui vont avoir des conséquences importantes sur les propositions thérapeutiques.
- **Les indications de traitement** sont systématiquement discutées et établies au cours d'une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) associant au minimum un chirurgien, un oncologue et un radiologue.
- **La prévention primaire et secondaire** de ces tumeurs repose sur la lutte contre le tabagisme et l'éthylisme chronique. La dimension sociale de la prise en charge de ces malades, prenant en compte toutes les réhabilitations nécessaires, fait partie du socle thérapeutique.

A 1. Généralités anatomiques des VADS

- Les cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) les plus fréquents touchent les structures suivantes (Figure 1) :
 - **la cavité buccale** : limitée par la voûte palatine en haut, les joues latéralement et le plancher buccal en bas ;
 - **l'oropharynx** : **situé en arrière de la cavité buccale** ; il comporte le voile du palais en haut, les loges amygdaliennes sur les côtés, la base de langue en avant, et la paroi pharyngée postérieure en arrière ;
 - **le cavum** : **situé en arrière des fosses nasales** et du voile du palais ; il remonte jusqu'à la base du crâne ; il comprend l'orifice des trompes d'Eustache ;
 - **les sinus ethmoïdaux** : cavités aériennes paires et médianes situées dans l'os ethmoïde entre les 2 orbites, en arrière des os du nez et sous l'étage antérieur de la base du crâne ;
 - **le pharynx** : conduit musculo-membraneux vertical, en avant du rachis, le pharynx part de la base du crâne. Il est séparé en trois étages, rhinopharynx au-dessus d'une ligne virtuelle passant par le plancher des fosses nasales, oropharynx entre cette limite et une ligne virtuelle passant par l'os hyoïde, hypopharynx en-dessous de l'os hyoïde jusqu'à la bouche de l'œsophage ;
 - **le larynx** : **situé là où l'appareil respiratoire et l'appareil digestif se séparent dans le cou.** Le larynx se trouve en avant de l'hypopharynx et relie le pharynx à la trachée. Le larynx mesure environ 5 cm de longueur. **Il se divise en 3 régions :**

- L'**étage sus-glottique** est situé dans le haut du larynx, au-dessus de la glotte. Sa principale composante est une languette cartilagineuse mobile appelée épiglotte.
- La **glotte** constitue la partie centrale du larynx. Elle contient les cordes vocales (parfois appelées replis vocaux). Les cordes vocales sont formées par une paire de muscles situés de chaque côté de l'ouverture de la trachée. Elles sont recouvertes d'une muqueuse.
- L'**étage sous-glottique** est situé à la base du larynx, entre la glotte et la trachée.

Figure 1. Voies aérodigestives supérieures. Coupe sagittale



Le larynx est constitué par un ensemble des tissus mous (muscles, ligaments, muqueuses) rigidifiés par un système de cartilages. L'épiglotte est attachée au cartilage thyroïde et bascule pour protéger la glotte et la trachée des fausses routes lors de la déglutition. Le pharynx part de la base du crâne. Il est séparé en trois étages, rinopharynx au-dessus d'une ligne virtuelle passant par le plancher des fosses nasales, oropharynx entre cette limite et une ligne virtuelle passant par l'os hyoïde, hypopharynx en-dessous de l'os hyoïde jusqu'à la bouche de l'œsophage.

- **les fosses nasales** : cavités limitées par l'orifice piriforme en avant, les choanes en arrière, l'os nasal et l'ethmoïde en haut, le maxillaire, la cloison inter sinus nasale latéralement, le palais (os maxillaire et os palatin), qui les séparent en bas de la cavité buccale.

B 2. Principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes ORL par localisation (hors glandes salivaires)

- Types histologiques bénins les plus fréquents en fonction de la topographie :

Topographie	Histologie
Cavité buccale	Leucoplasie (état pré-cancéreux)
Oropharynx Larynx Hypopharynx	Papillome
Fosses nasales et sinus	Papillome
Cavum	Polype antro-choanal Fibrome naso-sinusal

- Types histologiques malins les plus fréquents en fonction de la topographie :

Topographie	Histologie
Cavité buccale Oropharynx Larynx Hypopharynx	Carcinome épidermoïde+++ Lymphome malin de l'oropharynx
Fosses nasales et sinus	Adénocarcinome
Cavum	Carcinome indifférencié (<i>UCNT : undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type</i>) Lymphome malin

B 3. Histoire naturelle, facteurs de risque des cancers des VADS

3.1. Facteurs de risque

- Principaux facteurs de risque en fonction de la topographie :

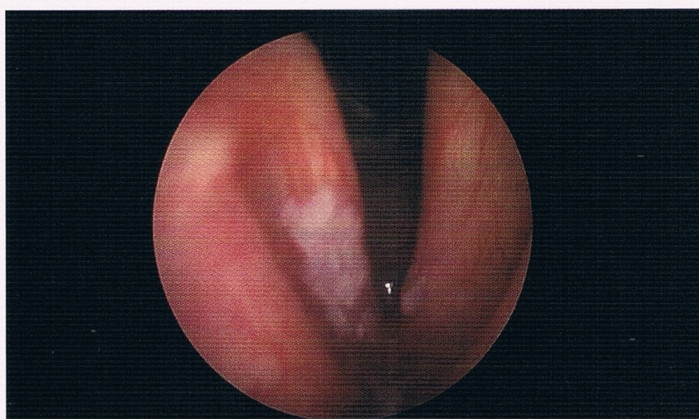
Topographie	Facteurs de risque
Cavité buccale	Alcool, tabac, Betel
Oropharynx	Alcool et tabac Papillomavirus (Virus HPV, le sérotype 16 étant de loin le plus fréquent)
Larynx	Alcool (sauf corde vocale), tabac et amiante
Hypopharynx	Alcool et tabac
Fosses nasales et sinus	Exposition professionnelle aux poussières de bois
Cavum	Virus EBV

- **Le risque de développer un cancer de la cavité buccale, du pharynx ou du larynx augmente avec la consommation d'alcool.** On estime que le risque de développer ces cancers chez les grands consommateurs d'alcool est multiplié par 45. Il a été démontré que le risque de développer un cancer des voies aérodigestives supérieures diminue après 10 ans d'arrêt de la consommation d'alcool et qu'après 20 ans, il ne diffère plus significativement de celui des personnes qui n'ont jamais bu.
- **Le risque de développer un cancer de la cavité buccale, du pharynx ou du larynx est lié au nombre de cigarettes fumées chaque jour mais surtout à la durée durant laquelle on a fumé.**
- **L'infection par HPV** est une maladie sexuellement transmissible.
- **Le diagnostic d'une tumeur causée par HPV** est fait à partir d'un prélèvement tumoral, soit par PCR qui est la méthode de référence, soit en recherchant l'expression en immunohistochimie de la protéine p16 (mais dont la corrélation n'est pas parfaite).
- **Les facteurs de risque d'une infection par HPV** sont les rapports bucco-génitaux et la multiplicité des partenaires sexuels.
- **Certains patients ont une tumeur causée à la fois par une intoxication alcool/tabac et par le virus HPV.**
- **À noter** que si la majorité de la population a été infectée par HPV au cours de sa vie, seule une partie présente un portage chronique et un plus faible nombre encore développera une tumeur oropharyngée liée à HPV.
- **La recherche de l'EBV** se fait par hybridation *in situ* à partir d'un prélèvement tumoral pour le cancer du cavum.
- L'adénocarcinome de l'ethmoïde est considéré comme une **maladie professionnelle** (travailleurs du bois) ; le cancer du larynx lié à l'amiante également.

3.2. Histoire naturelle

- **Histologiquement** apparaît d'abord une lésion précancéreuse (leucoplasie (**Figure 2**), érythroplasie, kératose, papillomatose) qui évolue vers une dysplasie puis un carcinome *in situ* qui se développe enfin en un carcinome invasif.

Figure 2. Leucoplasie : large plage de leucoplasie des deux tiers antérieurs de la corde vocale droite et petite tache leucoplasique de la corde vocale gauche en laryngoscopie indirecte au nasofibroscope



- **L'extension loco-régionale** se fait en superficie et en profondeur vers les muscles/os/cartilages avant d'atteindre les organes de voisinage.
- **L'extension à distance** se fait par :
 - **voie lymphatique** *via* les relais jugulo-carotidiens (les cancers des VADS sont très lymphophiles) ;
 - **voie hématogène** (essentiellement vers le poumon+++ , mais aussi le foie, les os, rarement le cerveau) ;
- **Les cancers synchrones ou métachrones sont fréquents** (ORL+++ , œsophage, poumon, vessie).

B 4. Généralités épidémiologiques des cancers des VADS

- Les cancers des VADS sont en 2023 au **6^e rang des cancers** les plus fréquents chez l'homme en France.
- Ils surviennent **principalement chez l'homme** (80 %).
- Avec un **pic de fréquence** entre 60 et 70 ans.
- Chez des patients ayant **le plus souvent un niveau socio-économique bas**.
- On observe **une baisse de l'incidence chez l'homme** (- 2,6 % par an sur la période 1990-2023) due à la baisse du tabagisme et de la consommation d'alcool.
- Mais **une augmentation de l'incidence chez la femme** (+1,6 % par an sur la période 1990-2023) du fait d'une augmentation du tabagisme et de la consommation d'alcool.
- En 2023, 13 900 personnes ont eu un diagnostic de cancer des VADS en France. Chaque année, 5000 patients en meurent.
- **Répartition topographique des cancers des VADS en France :**

Topographie	Répartition
Cavité buccale	20-25 %
Oropharynx	25 %
Larynx	30-35 %
Hypopharynx	15 %
Fosses nasales et sinus	< 1 %
Cavum	< 1 %

- **Particularités des cancers de l'oropharynx liés à l'HPV :**
 - sex ratio homme/femme à 2/1 environ ;
 - les patients sont plus jeunes (45-55 ans) ;
 - l'incidence augmente (ces cancers liés à l'infection virale représentent environ 30 % des cancers de l'oropharynx en France) ;
 - ont une classification TNM distincte en raison de leur meilleur pronostic.

A 5. Diagnostic positif

5.1. Circonstances de découverte

- Les cancers des VADS sont souvent pauci-symptomatiques.
- **Principaux signes cliniques selon la topographie tumorale :**

Topographie	Signes cliniques
Cavité buccale, oropharynx	Ulcération infiltrée, souvent indolore Tuméfaction Trouble de la mobilité linguale Otalgie réflexe Mobilité dentaire ou instabilité prothétique Gingivorragie Dysphagie Odynophagie Anesthésie du V3

Larynx	Dysphonie Dysphagie Dyspnée
Hypopharynx	Dysphagie Otalgie réflexe Dysphonie Douleur
Cavum	Signes rhinologiques : – Obstruction nasale – Rhinorrhée – Epistaxis Signes otologiques : – Dysfonction tubaire – Oreille bouchée – Hypoacousie Signes neurologiques : – Diplopie – Acouphènes – Névralgie du trijumeau
Ethmoïde	Signes rhinologiques : – Obstruction nasale – Rhinorrhée – Epistaxis – Anosmie Signes ophtalmologiques : – Paralysie oculomotrice – Exophtalmie Signes neurologiques : – Syndrome frontal – Névralgie du trijumeau
Toute topographie	Adénopathie cervicale isolée Otalgie réflexe Douleur

- Le caractère unilatéral et/ou la persistance dans le temps de ces signes doivent faire évoquer l'hypothèse d'un cancer.
- Un cancer des VADS doit également être suspecté en cas d'altération de l'état général et/ou d'amaigrissement chez un patient à risque.

5.2. Diagnostic de certitude

Il repose sur l'examen histologique de biopsies réalisées lors d'une panendoscopie des VADS :

(Attention : élément fondamental à ne jamais oublier)

- l'examen est systématique ;
- il se fait sous anesthésie générale ;
- il explore la cavité buccale (**Figure 3**), l'oro (**Figure 4**) et l'hypo-pharynx, le larynx (**Figure 5**), et la partie supérieure de l'œsophage ;
- il permet la réalisation de biopsies guidées ;
- il s'accompagne d'un compte rendu avec schéma daté et signé et éventuellement d'un enregistrement vidéo.

Figure 3.  Contenu multimédia. Langue : carcinome épidermoïde T1 de langue mobile gauche.



Figure 4. A.  Contenu multimédia. Hypopharynx : carcinome épidermoïde T4 du sinus piriforme gauche en laryngoscopie directe lors d'une panendoscopie.

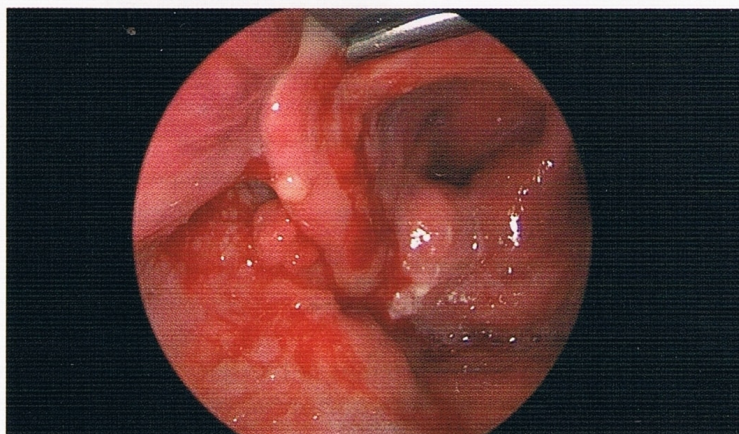


Figure 4.B.  Contenu multimédia. Amygdale droite : carcinome épidermoïde T4 de la région amygdalienne droite à l'examen au fauteuil à l'abaisse langue.

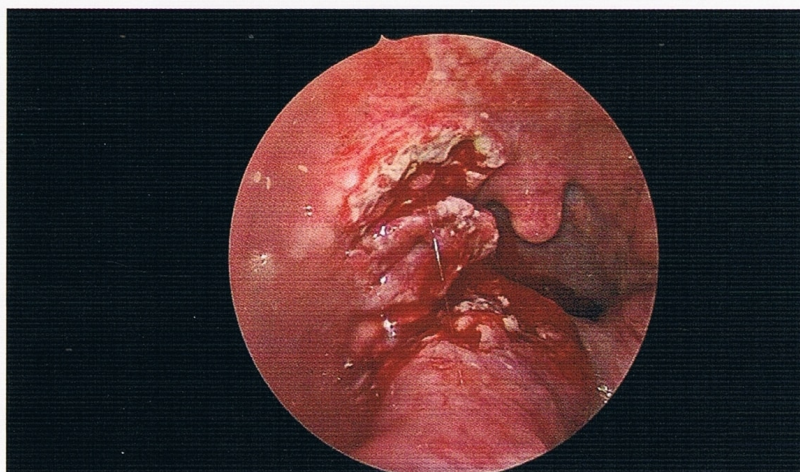
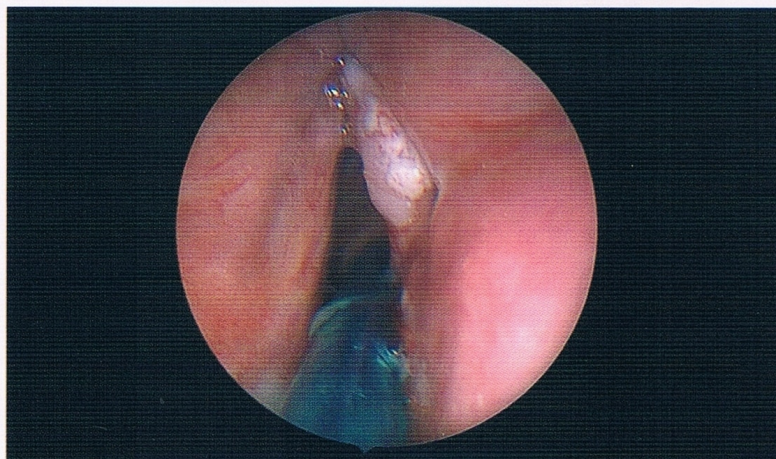


Figure 5. Larynx : carcinome épidermoïde T1 de la corde vocale droite en laryngoscopie directe lors d'une panendoscopie.



B 6. Éléments du bilan des cancers des VADS

6.1. Bilan d'extension

- Tomodensitométrie cervico-thoracique avec injection de produit de contraste.
- IRM s'il s'agit d'un cancer du cavum, de l'oropharynx ou de la cavité buccale.

Se souvenir : TDM toujours nécessaire dans le bilan + IRM pour bilan en cas de lésions situées au-dessus de l'os hyoïde.

- Tomographie par émission de positons (TEP) : elle est indiquée devant un ganglion métastatique d'un cancer primitif inconnu ou en cas de maladie à haut risque métastatique (> N2b).

6.2. Bilan pré-thérapeutique

- **Bilan odontologique** : consultation spécialisée avec réalisation d'un orthopantomogramme. Des soins conservateurs, voire des avulsions dentaires, doivent être effectués si nécessaire et réalisation de gouttière de fluoruration pour prévention de l'ostéoradionécrose.

Ce bilan est fondamental afin de limiter le risque d'infection ou d'avulsion sur mâchoire irradiée, avec un risque d'ostéoradionécrose.

- Bilan nutritionnel ;
- **Bilan respiratoire** : le scanner thoracique est fait de façon systématique, éventuellement complété par une épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR) ;
- Bilan cardiovasculaire ;
- Bilan biologique complet ;
- Bilan gériatrique (au-delà de 70 ans), le cas échéant ;
- Bilan des addictions, en particulier évaluer risque de delirium tremens.

6.3. Classification TNM

La classification TNM des VADS ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

- La classification TNM varie selon les localisations et le statut HPV.
- Les cancers du cavum ont une classification à part.
- Le statut M est simple, M0 signifiant l'absence de métastase à distance, et M1 la présence de métastase(s) à distance.
- Cavité buccale et oropharynx :

T1	≤ 2 cm
T2	2 à 4 cm
T3	> 4 cm
T4	Envahissement du voisinage

- Larynx et hypopharynx :

T1	1 seule localisation du pharynx ou du larynx avec mobilité laryngée conservée (cordes vocales mobiles)
T2	Plusieurs localisations du pharynx ou du larynx avec mobilité laryngée conservée
T3	Plusieurs localisations du pharynx ou du larynx avec une ou les 2 cordes vocales fixées
T4	Extension aux structures du voisinage (cartilage, os, peau)

- La classification N est commune aux cancers de la cavité buccale, de l'oropharynx, du larynx et de l'hypopharynx :

No	Pas d'adénopathie
N1	1 adénopathie homolatérale ≤ 3 cm
N2a N2b N2c	1 adénopathie homolatérale entre 3 cm et 6 cm Adénopathies multiples homolatérales ≤ 6 cm Adénopathies bilatérales ≤ 6 cm
N3	Adénopathie(s) > 6 cm ou rupture capsulaire

7. Évolution et pronostic

Ces notions ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

7.1. Cancers de l'oropharynx, hypopharynx, larynx et de la cavité buccale

- Le pronostic des cancers de stade localisé est essentiellement loco-régional, avec un risque de récurrence faible, mais présente un enjeu fonctionnel majeur. Le pronostic est loco-régional et à distance (essentiellement pulmonaire) pour les cancers avec envahissement ganglionnaire important, avec un risque de récurrence de l'ordre de 50 %. Le pronostic est meilleur si le cancer est développé dans le contexte d'une infection à virus HPV.

- Chez les patients survivants à long terme, le risque de développer un second cancer sur la même muqueuse à risque, dans un territoire adjacent à celui traité ou sur un autre organe, surtout en absence d'arrêt des intoxications alcoolique et tabagique, est de 20 % à 5 ans.
- Le pronostic des patients éthylo-tabagiques est également lié aux comorbidités cardiovasculaires et pulmonaires.

7.2. Tumeurs des fosses nasales et des sinus

- Le pronostic de ces cancers est essentiellement local. Le risque d'extension ganglionnaire est faible. Les évolutions métastatiques concernent surtout le poumon.

7.3. Tumeurs du cavum

- Les cancers indifférenciés du cavum, liés à l'EBV, s'accompagnent souvent d'un envahissement ganglionnaire (80 % des cas au diagnostic) qui est bilatéral dans 50 % des cas (ganglions rétro-pharyngés et postérieurs). Leur pronostic est meilleur que celui de la majorité des cancers épidermoïdes des VADS liés au tabac et à l'alcool.
- La surveillance de tous ces cancers se fait par l'examen clinique et par l'imagerie.

A 8. Généralités sur la prévention en cancérologie des VADS

- La lutte contre le tabagisme et l'éthylisme chronique est un objectif de santé publique afin de diminuer la prévalence des cancers des voies aérodigestives supérieures.
- Concernant les cancers de l'oropharynx liés à l'HPV dont la prévalence augmente, un programme de vaccination des garçons et des filles est proposé au collège afin de tenter d'éradiquer complètement l'infection par l'HPV.

9. Approches thérapeutiques

Le traitement des tumeurs des VADS ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

9.1. Principes généraux

9.1.1. Chirurgie

- La chirurgie est indiquée sur les tumeurs dont le stade autorise la résécabilité. En général, la chirurgie concerne le site primitif et les aires ganglionnaires cervicales. L'utilisation de lambeaux de recouvrement est possible.

9.1.2. Radiothérapie

- La radiothérapie est utilisée dans 95 % des cancers ORL en traitement exclusif ou post-opératoire, seule ou associée à une chimiothérapie concomitante. Elle est fractionnée et s'étale sur 6 à 7 semaines selon qu'elle est post-opératoire ou exclusive.
- La toxicité aiguë intervient après 3 semaines de traitement et comporte principalement 5 effets principaux :
 - la radiomucite (qui disparaît un mois après la fin de la radiothérapie) ;
 - la radiodermite (qui disparaît également un mois après la fin de la radiothérapie) ;
 - la dysgueusie (qui disparaît plusieurs mois après la fin de la radiothérapie) ;
 - l'hyposialie (qui disparaît 2 ans après la fin de la radiothérapie s'il y a eu traitement en radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité (RCMI). En cas d'irradiation conventionnelle, elle est définitive) ;
 - l'hypothyroïdie.

- **La toxicité tardive** n'est pas systématique et peut survenir plusieurs années après le traitement. Il peut s'agir :
 - d'ostéoradionécrose, favorisée par des gestes d'avulsion dentaire ;
 - de fibrose buccale et cervicale.

9.1.3. Chimiothérapie

- **La chimiothérapie des cancers ORL peut être prescrite dans plusieurs circonstances :**
 - **En situation néo-adjuvante** dans un contexte le plus souvent de tentative de préservation d'organe (carcinome épidermoïde du larynx). Il s'agit d'un traitement faisant appel ici à une poly-chimiothérapie par cisplatine, 5 fluoro-uracile (5FU) et docétaxel dont l'objectif est de réduire la taille tumorale de 80 % à l'issue des 3 premiers cycles pour envisager alors l'irradiation de la tumeur dans un objectif curatif.
 - **De façon concomitante à la radiothérapie**, soit en post-opératoire (pour les carcinomes épidermoïdes à haut risque de rechute), soit dans le cadre d'une chimio-radiothérapie exclusive (lorsque la tumeur est en place). La molécule de référence est le cisplatine. Le cetuximab peut être proposé en cas de contre-indication au cisplatine, mais uniquement en association à la radiothérapie sur tumeur en place (pas en post-opératoire).
 - **Dans un contexte palliatif** : pour un cancer métastatique d'emblée ou en raison d'une rechute (loco-régionale et/ou métastatique). Le traitement de référence en première ligne consiste soit en une immunothérapie par pembrolizumab (si CPS ≥ 1) seul ou en association avec des sels de platine et du 5FU, soit en une association par cisplatine, docétaxel et cetuximab. À noter que si le pourcentage de patients tirant bénéfice de l'immunothérapie est modeste, des réponses complètes prolongées sont régulièrement observées.

Dans tous les cas, le taux élevé de comorbidités des patients ORL nécessite que ces traitements soient délivrés en milieu spécialisé par des oncologues ayant l'expérience de ces patients.

9.2. Cancers de l'oropharynx, hypopharynx, larynx et de la cavité buccale

- **Le traitement des cancers de la cavité buccale** met en jeu la préservation des fonctions masticatoire, d'élocution, de déglutition et la restauration prothétique dentaire. Classiquement, le traitement est chirurgical en premier, suivi - selon les facteurs pronostiques reconnus à l'examen de la pièce opératoire - d'une radiothérapie ou d'une chimio-radiothérapie post-opératoire. Les réhabilitations sont envisagées après cicatrisation complète, au minimum 3 mois après la fin des traitements.
- **Le traitement des cancers de l'oropharynx** peut être également chirurgical mais est plus fréquemment basé sur une radiothérapie exclusive ou une chimio-radiothérapie devant une maladie localement avancée.
- **La problématique des cancers du larynx et de l'hypopharynx** repose sur le respect de l'intégrité des filières aéro-digestives. Les protocoles de préservation laryngée évitent à plus de 70 % des patients une laryngectomie totale avec trachéotomie définitive. L'apprentissage de la voix œsophagienne doit débuter dès la cicatrisation de la mucite post-radique obtenue.

9.3. Tumeurs des fosses nasales et des sinus

- Le problème majeur de la prise en charge concerne la reconstruction suivant l'exérèse. Les techniques modernes de radiothérapie ont considérablement réduit les risques de toxicité oculaire.

9.4. Tumeurs du cavum

- Le traitement repose sur une association chimio-radiothérapie avec des sels de platine. L'irradiation se complique fréquemment d'une otite séreuse qui doit souvent être drainée.

Principales situations de départ en lien avec l'item 298 :
« Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum,
et des voies aéro-digestives supérieures »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
314. Prévention des risques liés au tabac	La prévention primaire et secondaire de ces tumeurs repose sur la lutte contre le tabagisme et l'éthylisme chronique.
303. Prévention / dépistage des cancers de l'adulte	
Signes cliniques en lien avec la localisation cervico-faciale	
14. Émission de sang par la bouche	Les cancers de l'oropharynx sont la plupart du temps révélés par une dysphagie haute, une otalgie homolatérale et une adénopathie cervicale. Toute gêne pharyngée ou otalgie réflexe apparue chez un adulte, sans terrain infectieux évident, doit faire penser à une tumeur de l'oro ou de l'hypopharynx. La dysphonie est le symptôme principal des tumeurs du plan glottique (cordes vocales). Le cancer du cavum peut se présenter sous la forme d'une adénopathie cervicale isolée. Ce cancer peut être suspecté devant des symptômes naso-sinusiens, otologiques (surtout unilatéraux) et des signes neurologiques en rapport avec une extension basi-crâniennes (paires V, VI et IX essentiellement). Un bilan chez un spécialiste ORL doit être envisagé en première intention dans ce contexte.
16. Adénopathies unique ou multiples	
52. Odynophagie/dysphagie	
62. Troubles de déglutition ou fausse route	
140. Baisse de l'audition/surdité	
143. Diplopie	
144. Douleur cervico-faciale	
145. Douleur pharyngée	
146. Dysphonie	
147. Épistaxis	
150. Limitation de l'ouverture buccale	
153. Otalgie	
155. Rhinorrhée	
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	
30. Dénutrition/malnutrition	
31. Perte d'autonomie progressive	
En lien avec le bilan diagnostique du cancer des VADS	
178. Demande / prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Le diagnostic de certitude d'un cancer des VADS repose sur l'examen histologique en anatomo- pathologie de biopsies réalisées sous endoscopie des VADS. Ne pas oublier l'évaluation du statut viral des tumeurs du cavum (EBV) ou de l'oropharynx (HPV). Pour le bilan d'extension loco-régional, une imagerie par IRM est plutôt recommandée pour les tumeurs situées au-dessus de l'os hyoïde, tandis que le scanner est recommandé pour les tumeurs situées au-dessous de l'os hyoïde.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier / reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie (bronchiques, digestifs)	
238. Demande et préparation aux examens endoscopiques (ORL)	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire / biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomopathologie	

